

Чек-лист самопроверки: 6 направлений для оценки возможных причин недомогания

Если вы чувствуете хроническую усталость, нестабильность веса, перепады настроения, а анализы показывают «всё в норме», этот чек-лист поможет вам системно оценить возможные причины недомогания, включая гормональный дисбаланс, дефициты или системные сбои. Это не заменяет медицинскую диагностику, но поможет вам лучше понять своё состояние и подготовиться к консультации.

Важно: некоторые лекарства (например, биотин) могут искажать результаты анализов, особенно щитовидной железы. Упомяните о принимаемых препаратах при консультации.

1. Гормоны щитовидной железы

- **Признаки для проверки:**
 - Чувствуете ли вы постоянную усталость, даже после сна?
 - Замечаете ли вы сухость кожи, выпадение волос или чувство холода?
 - Стали ли у вас чаще возникать запоры или проблемы с концентрацией?
- **Если вы отмечаете несколько из этих признаков, рекомендуется сдать:** ТТГ (TSH, гормон, регулирующий щитовидную железу), свободный Т3, свободный Т4, антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) и к тиреоглобулину (анти-ТГ, для выявления аутоиммунных проблем щитовидки).
- **Почему важно:** Щитовидная железа регулирует обмен веществ, энергию и настроение. Анти-ТПО и анти-ТГ помогают выявить аутоиммунный тиреоидит (например, болезнь Хашимото).
- **Примечание:** Нормальные значения зависят от лаборатории, но, например, ТТГ обычно в диапазоне 0.4–4.0 мкМЕ/мл. Повторные анализы рекомендуются через 6–8 недель при отклонениях.

2. Надпочечники и кортизол

- **Признаки для проверки:**
 - Трудно ли вам просыпаться по утрам, даже после долгого сна?
 - Испытываете ли вы тягу к сладкому или солёному в течение дня?
 - Беспокоят ли вас тревожность или проблемы со сном?
- **Если вы отмечаете несколько из этих признаков, рекомендуется сдать:** Кортизол (гормон стресса, лучше проверять в суточной моче или слюне в 4 точки; в крови — утром 7:00–9:00 и вечером 16:00–18:00), ДГЭА-С (гормон надпочечников). АКТГ (регулятор кортизола) и дексаметазоновый тест (для исключения синдрома Кушинга) назначаются по показаниям.

- **Почему важно:** Надпочечники отвечают за стрессоустойчивость и энергию. Дисбаланс кортизола может вызывать слабость и эмоциональную нестабильность.
- **Примечание:** Нормы кортизола зависят от времени суток (утром: 7–25 мкг/дл в крови). Повторные тесты — через 4–6 недель при необходимости.

3. Уровень железа и ферритин

- **Признаки для проверки:**
 - Замечаете ли вы бледность кожи или частую одышку?
 - Ломаются ли ваши ногти или выпадают волосы?
 - Чувствуете ли вы головокружение или слабость при физической нагрузке?
- **Если вы отмечаете несколько из этих признаков, рекомендуется сдать:** Ферритин (запасы железа в организме), сывороточное железо, трансферрин, общая железосвязывающая способность (ОЖСС — показатель, как организм связывает железо).
- **Почему важно:** Ферритин — наиболее чувствительный маркер скрытого дефицита железа, который снижает доставку кислорода к тканям, вызывая слабость.
- **Примечание:** Ферритин обычно в норме 30–200 нг/мл (у женщин) и 40–300 нг/мл (у мужчин). Повторные анализы — через 8–12 недель после коррекции.

4. Витамины и микроэлементы

- **Признаки для проверки:**
 - Чувствуете ли вы хроническую усталость или раздражительность без причины?
 - Беспокоят ли вас мышечные спазмы или судороги?
 - Часто ли вы болеете из-за слабого иммунитета?
- **Если вы отмечаете несколько из этих признаков, рекомендуется сдать:** Витамин D (25(OH)D — показатель уровня витамина D), витамин B12, фолиевая кислота, магний, цинк, селен (важен для щитовидной железы), витамин B6. При низком B12 может быть рекомендован анализ на гомоцистеин или метилмалоновую кислоту (для исключения скрытого дефицита B12).
- **Почему важно:** Дефицит этих веществ нарушает работу нервной системы, обмен веществ и иммунитет. Селен особенно важен для щитовидной железы.
- **Примечание:** Норма витамина D: 30–100 нг/мл; B12: 200–900 пг/мл. Повторные анализы — через 3–6 месяцев после коррекции.

5. Половая гормональная система

Для женщин

- **Признаки для проверки:**
 - Есть ли у вас нерегулярный менструальный цикл или болезненные менструации?
 - Замечаете ли вы резкие перепады настроения или снижение либидо?
 - Наблюдаете ли вы необъяснимый набор веса?
- **Если вы отмечаете несколько из этих признаков, рекомендуется сдать:** Эстрадиол, прогестерон, тестостерон, ЛГ, ФСГ (на 3–5 и 21–23 дни цикла), антимюллеров гормон (АМГ — показатель запаса яйцеклеток). Для женщин 45+ — ФСГ для оценки перименопаузы.
- **Почему важно:** Дисбаланс половых гормонов влияет на настроение, вес, сон и общее самочувствие. Анализы в определённые дни цикла обеспечивают точные результаты.
- **Примечание:** Нормы зависят от фазы цикла (например, эстрадиол: 30–400 пг/мл в фолликулярной фазе). Повторные анализы — через 1–2 цикла.

Для мужчин

- **Признаки для проверки:**
 - Чувствуете ли вы снижение либидо или проблемы с эрекцией?
 - Замечаете ли вы уменьшение мышечной массы или хроническую усталость?
 - Беспокоят ли вас раздражительность или снижение энергии?
- **Если вы отмечаете несколько из этих признаков, рекомендуется сдать:** Общий и свободный тестостерон, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, глобулины, связывающие половые гормоны (SHBG — белок, регулирующий доступность гормонов).
- **Почему важно:** Тестостерон регулирует энергию, мышечную массу, либидо и настроение. Дисбаланс может быть связан с низким уровнем тестостерона или избытком эстрогенов.
- **Примечание:** Норма общего тестостерона: 300–1000 нг/дл (у мужчин). Повторные анализы — через 3–6 месяцев.

6. Общее состояние организма

- **Признаки для проверки:**
 - Испытываете ли вы постоянную жажду или скачки веса?
 - Чувствуете ли вы хроническую усталость или боли в суставах?
 - Замечаете ли вы ухудшение общего самочувствия без явных причин?
- **Если вы отмечаете несколько из этих признаков, рекомендуется сдать:** Общий анализ крови, глюкоза, инсулин (для расчёта HOMA-IR — индекса, показывающего, как организм реагирует на инсулин), HbA1c (средний уровень сахара за 2–3 месяца),

липидный профиль, маркеры воспаления (СРБ), креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ — показатель работы почек), АЛТ, АСТ (ферменты печени), общий белок, альбумин.

- **Почему важно:** Системные сбои, такие как инсулинорезистентность (высокий НОМА-IR может указывать на риск диабета), хроническое воспаление, нарушения функции почек или печени, могут быть скрытой причиной недомогания.
- **Примечание:** Норма HbA1c: <5.7%; креатинин: 0.6–1.2 мг/дл. Повторные анализы — через 3–6 месяцев.

Как использовать чек-лист

1. **Запишите симптомы:** Ведите дневник симптомов в течение 1–2 недель, отмечая, что беспокоит больше всего.
2. **Сдайте анализы:** Обратитесь в лабораторию для сдачи указанных анализов. Для женщин уточните фазу цикла, а также сообщите о принимаемых препаратах.
3. **Получите консультацию:** Для интерпретации результатов и дальнейших шагов свяжитесь со мной в WhatsApp/Telegram, чтобы обсудить ваши симптомы и анализы.
4. **Начните с простых шагов:** Нормализуйте сон, питание и уровень стресса, чтобы поддержать организм.

Что дальше?

Если вы чувствуете, что с организмом что-то не так, не игнорируйте симптомы. Усталость, перепады настроения или изменения веса могут быть связаны с гормональным дисбалансом, дефицитом микроэлементов, хроническим стрессом или другими системными сбоями. Напишите мне в WhatsApp/Telegram — я помогу разобраться в ваших симптомах, проанализировать результаты анализов и предложу план действий для улучшения самочувствия.